HÔPITAUX Paris
Saint Joseph
Marie Lannelongue

Infirmier organisateur de l'accueil – Cas cliniques préparatoires

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Sommaire

- 1 : Chute VP – Mr A
- 2 : Douleur thoracique – Me B
- 3 : AES – Mr C
- 4 : Douleur abdominale – Me D
- 5 : AVC – Mr E
- 6 : Anomalie BS (HypoK+) – Me F
- 7 : AEG – Mr G
- 8 : Confusion – Me H
- 9 : Dyspnée – Mr I
- 10 : Plaie – Me J
- 11 : Toux – Mr K
- 12 : Douleurs lombaires – Me L
- 13 : Crise convulsive – Mr M
- 14 : AVP – Me N
- 15 : Panaris – Mr O
- 16 : Hémorroïde – Me P
- 17 : Douleur M.I – Mr Q
- 18 : Traumatisme cheville – Me R
- 19 : OMI - Mr S
- 20 : Psychiatrie– Mr T

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Consignes

Pour chaque clinique, aidez-vous en réalisant ces tableaux :

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

P.V	Autres
Fréquence cardiaque	Hémocue
Saturation en Oxygène	Cushmann
Tension artérielle	Bladder scan
Glasgow	Ethylotest
Douleur	Cétonémie
Température	…
Fréquence respitaoire	

Puis, rédiger vos IOA comme nous l'avons vu lors de la formation

Me W, 31 ans.

Patiente vient pour douleurs au niveau de l'hypochondre droit.
Douleur d'apparition brutale ce jour vers 18h, avec nausées sans vomissements.
Pas de SFU, pas de troubles du transit associés.
DDR : Il y a 2 semaines, patiente sous contraception et pas de risque de grossesse.

A l'IOA, douleurs présente, intensifié à la palpation, sans irradiation.
Abdomen souple.
Présente des nausées.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 1

Monsieur A, 78 ans

Motif : Chute sur la VP, plaie arcade sourcilière Gauche

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 1 – M. A

M. A. est autonome, il vit avec sa femme à domicile sans aide.

Ce jour, en allant chercher son pain, il a trébuché sur le trottoir et est tombé.

Il arrive aux urgences par ses propres moyens. Il présente une plaie à l'arcade sourcilière gauche de 2 cm.
La plaie ne saigne pas, mais il a du sang séché sur le visage. M. A. a protégé la plaie avec un mouchoir qu'il avait dans sa poche.

Il précise qu'il se souvient de tout et n'a pas perdu connaissance.

Il n'a pas de douleur, pas de céphalées, pas de nausées/vomissements et aucun vertige : *« Je suis quand même venu jusqu'à vous tout seul. »*

Ce n'est pas la première fois qu'il chute : *« J'ai déjà fait des chutes, mais c'est la première fois que je m'ouvre en 70 ans. »*

M. A. est suivi dans votre hôpital pour une ACFA et de l'HTA. Il prend de l'Amlor® 10 mg 3 fois par jour et de l'Eliquis® 2,5 mg 2 fois par jour.

- Si pas Hémocue : diapo suivante.
- Si Hémocue : passer la prochaine diapo.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 1 – M. A

Si vous décider de ne pas faire d'Hémocue

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	86 batt/min
Saturation en oxygène	100%
TA systolique	142 mmHg
TA diastolique	87 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 0/10
Température	37°1C
Fréquence respiratoire	16 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 1 – M. A

Si vous décider de faire un Hémocue

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	86 batt/min
Saturation en oxygène	100%
TA systolique	142 mmHg
TA diastolique	87 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 0/10
Température	37°1C
Fréquence respiratoire	16 mvt/min
Autres (Hémocue)	1 : 13,8 ; 2 : 12,9 ; Moyenne : 13,35

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 2

Madame B, 36 ans

Motif : Douleur thoracique

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 2 – Mme B.

Mme B. a 36 ans, elle vit seule avec ses deux enfants de 8 et 10 ans. Elle travaille en tant qu'agent de caisse dans un supermarché.
Aujourd'hui, vers 10h, elle est prise d'une douleur thoracique alors qu'elle était assise à son poste de travail. Ses collègues ont appelé le SAMU qui est arrivé sur place, a effectué un ECG et un bilan médical.

Le bilan étant rassurant et l'ECG sans anomalie, la patiente a été conduite au SAU par les pompiers.

À son arrivée au SAU à 10h45, le pompier vous transmet : Patiente de 36 ans, douleur thoracique localisée en bas thoracique avec irradiation dans le bras gauche, régulée SAMU avec ECG sans anomalie.
Il vous transmet également que la patiente est DNID et a déjà fait un infarctus en 2018.
Elle prend du Glucophage® 1g, 3x/j et du Xarelto® 20mg 1x/j.

À l'IOA, la patiente vous explique que la douleur l'oppresse et qu'elle a du mal à respirer.
Elle précise : *« J'ai l'impression de ne pas réussir à remplir entièrement mes poumons. »*

En poursuivant l'entretien, Mme B. vous indique que la douleur est toujours présente et que, depuis 10h, elle n'a jamais cessé. Elle ajoute : *« Je ne suis même pas soulagée quand je change de position, même quand je me penche en avant. »*
L'ECG réalisé par le SAMU n'étant pas présent dans le dossier, vous en effectuez un à nouveau.

La patiente vous confirme les antécédents transmis par les pompiers. Elle ajoute : *« J'ai déjà eu un infarctus et franchement, c'est la même douleur actuellement. J'ai l'impression que ça recommence ! J'aurais dû arrêter de fumer comme me l'avait conseillé le cardiologue. »*

1. Vous faites réguler l'ECG. Le MAO vous confirme qu'il est normal et superposable à l'ancien ECG présent dans le dossier.
2. Vous faites réguler l'ECG à nouveau. Le MAO vous confirme que l'ECG est modifié avec une onde Q anormale.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 2 – Mme B.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	98 batt/min
Saturation en oxygène	95%
TA systolique	175 mmHg
TA diastolique	97 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 7/10
Température	36°8C
Fréquence respiratoire	18
Autres (HGT)	181 mg/dL

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA Situation 1 ?

→ Tri IOA situation 2 ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 3

Monsieur C, 24 ans

Motif : AES

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 3 – M. C.

M. C. a 24 ans, il est étudiant en droit à la faculté de Paris.

Hier soir, lors d'une soirée festive avec des amis pour fêter la fin des partiels, il a eu un rapport sexuel non protégé, dans un contexte d'alcoolisation.

Aujourd'hui, M. C. a des remords et vous dit : *« J'ai peur d'avoir attrapé le SIDA. »*

Il ne connaissait pas la personne avec qui il a eu le rapport, car il l'a rencontrée dans la soirée et n'a aucun lien avec elle.

M. C. n'a aucun antécédent et ne prend pas de traitement.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 3 – M. C.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	108 batt/min
Saturation en oxygène	99%
TA systolique	152 mmHg
TA diastolique	88 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 0/10
Température	36°8C
Fréquence respiratoire	12
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 4

Madame D, 42 ans

Motif : Douleur abdominale

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 4 – Mme. D.

Mme D. a 42 ans. Elle vit avec son époux et ses enfants. Elle est agent immobilière.

Cette nuit, vers 4 h du matin, elle a été réveillée par une douleur abdominale intense, apparue brutalement.

Elle s'est levée et a pris deux comprimés de Spasfon® qu'elle avait dans son placard de salle de bain.

Après la prise de l'antispasmodique, elle a pu se recoucher et dormir un peu, mais la douleur est revenue vers 6 h. Elle précise que la douleur *« vient par spasmes, puis ensuite ça se calme ».*

Ce matin, elle a pris son petit-déjeuner comme d'habitude, puis 30 minutes plus tard, la douleur est réapparue et elle a eu un épisode de vomissement : *« J'ai vomi tout ce que j'avais mangé. »*

Lors de votre entretien, vous demandez à Mme D. si elle présente des signes fonctionnels urinaires et/ou des troubles digestifs, ce qu'elle nie.
Elle vous montre que la douleur se situe au niveau de l'hypochondre droit.

Mme D. a déjà été opérée pour une césarienne, une appendicectomie et une cholécystectomie.

Elle ne prend pas de traitement.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 4 – Mme. D.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	77 batt/min
Saturation en oxygène	100%
TA systolique	162 mmHg
TA diastolique	98 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 8/10
Température	37°3C
Fréquence respiratoire	16
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 5

Monsieur E, 91 ans

Motif : AVC

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 5 – M. E.

M. E. a 91 ans. Il vit à l'EHPAD « La Belle Vie » depuis 10 ans. Il arrive au SAU par ambulance.

L'ambulancier vous transmet le dossier du patient ainsi que la lettre du médecin mentionnant le motif d'admission : suspicion d'AVC.

À l'IOA, M. E. est mutique. Il présente une paralysie faciale droite ainsi qu'une hémiplégie complète de l'hémicorps droit.
De plus, il est très spastique, ce qui le rend difficilement mobilisable et complique son déshabillage.

Grâce au dossier de l'EHPAD et au courrier du médecin, vous apprenez que :

- **GIR** : 2
- **Antécédents** : Maladie de Parkinson, HTA, cardiopathie ischémique, cataracte bilatérale, troubles mnésiques, troubles sphinctériens.
- **Traitements** : Lercan® 10 mg 2x/jour, Doliprane® 1 g 3x/jour, Bisoprolol® 2,5 mg 1x/jour, Triatec® 2,5 mg 2x/jour, Modopar® 125 mg 4x/jour.

Transmissions IDE :

- Retrouvé à 7 h du matin dans son lit avec une paralysie de l'hémicorps droit.
- Depuis une semaine, refus de s'alimenter et difficultés à la prise des traitements (certaines doses non administrées).

➢ Si pas HGT : diapo suivante.
➢ Si HGT : passer la prochaine diapo.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 5 – M. E.

Si vous décider de ne pas faire de Glycémie (HGT)

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	87 batt/min
Saturation en oxygène	94%
TA systolique	176 mmHg
TA diastolique	101 mmHg
Glasgow	9
Douleur	Algoplus : 0
Température	36°9C
Fréquence respiratoire	10 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 5 – M. E.

Si vous décider de faire une Glycémie (HGT)

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	87 batt/min
Saturation en oxygène	94%
TA systolique	176 mmHg
TA diastolique	101 mmHg
Glasgow	9
Douleur	Algoplus : 0
Température	36°9C
Fréquence respiratoire	10 mvt/min
Autres (HGT)	86 mg/dL

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 6 – Mme F.

Madame F, 19 ans

Motif : Anomalie BS (HypoKaliémie)

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 6 – Mme F.

Mme F. a 19 ans. Elle est adressée par son médecin généraliste pour une prise en charge d'une anomalie biologique détectée sur un bilan sanguin.

Ce bilan a été réalisé la veille, à la suite d'une consultation pour asthénie et une perte de poids de 4 kg en deux semaines.

Sur le bilan sanguin réalisé la veille, vous remarquez :

- **Sodium** : 137 mmol/L
- **Potassium** : 2,2 mmol/L
- **Chlore** : 105 mmol/L
- **Créatinine** : 113 µmol/L
- **Urée** : 5,7 mmol/L

La patiente affirme n'avoir aucun antécédent, mais sa maigreur vous interroge sur une possible pathologie psychiatrique sous-jacente.
Elle vous dit : *« Je n'ai aucun problème de santé, par contre je fume. »*

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 6 – Mme F.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	55 batt/min
Saturation en oxygène	99%
TA systolique	98 mmHg
TA diastolique	56 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 0/10
Température	36°5C
Fréquence respiratoire	12 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 7

Monsieur G, 52 ans

Motif : AEG

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 7 – M. G.

M. G. a 52 ans. Il est originaire du Sénégal et vient de rentrer en France après y avoir séjourné pendant six mois.

Il se présente aujourd'hui au SAU pour une altération de l'état général avec une asthénie évoluant depuis environ un mois. Il n'a pas consulté de médecin généraliste.

Pendant l'IOA, M. G. vous dit : *« En plus d'être fatigué, je n'arrête pas d'aller aux toilettes pour faire pipi. »*

Il précise également : *« Je suis diabétique depuis 10 ans, je prends de la metformine, mais je ne l'ai pas prise depuis deux semaines car je n'avais plus d'ordonnance et j'étais au Sénégal. »*

Lorsque vous lui demandez s'il boit beaucoup d'eau ces derniers temps, il répond : *« Oui, je ne fais que ça, plus d'un litre par jour. »*

Vous réalisez une glycémie qui est à 381 mg/dL, puis une cétonémie à 1,4 mmol/L.

M. G. pèse 116 kg pour 1,84 m.

- Si pas HGT : diapo suivante.
- Si HGT : passer la prochaine diapo.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 7 - M. G.

Si vous décider de ne pas faire de Glycémie (HGT)

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	98 batt/min
Saturation en oxygène	100%
TA systolique	146 mmHg
TA diastolique	92 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 2/10
Température	37°1C
Fréquence respiratoire	16 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 7 – M. G.

Si vous décider de faire une Glycémie (HGT)

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	98 batt/min
Saturation en oxygène	100%
TA systolique	146 mmHg
TA diastolique	92 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 2/10
Température	37°1C
Fréquence respiratoire	16 mvt/min
Autres (HGT + Cétonémie)	HGT : 386 mg/dL Cétonémie : 1,6

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 8

Madame H, 78 ans

Motif : Confusion

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 8 – Mme. H.

Mme H. a 78 ans. Elle se présente au SAU accompagnée de sa fille et transportée par une société d'ambulance.

Les ambulanciers vous transmettent que Mme H. vient pour un épisode de confusion depuis ce matin, selon les dires de sa fille.

Cette dernière coupe la parole aux ambulanciers pendant les transmissions et s'exclame : *« C'est le SAMU qui nous a dit de venir, elle fait un AVC, c'est une urgence ! »*

Vous lui rappelez les règles de l'IOA et lui dites que vous allez prendre en charge sa mère dans un court instant.

À l'IOA, Mme H. est confuse. Elle ne sait pas indiquer la date du jour, ni le mois, ni l'année. Elle semble perdue et paniquée.

Vous décidez d'approfondir l'entretien avec sa fille, qui vous rapporte les éléments suivants :
« Je suis allée rendre visite à maman, comme tous les mercredis. Quand je suis arrivée, elle était encore au lit et en pyjama. Maman a l'habitude de se lever tôt, et elle est très coquette, donc elle aime être bien apprêtée. J'ai été surprise de la trouver encore au lit. »
Elle ajoute : *« Puis, quand je suis allée la voir, elle ne m'a pas reconnue, donc j'ai paniqué et j'ai appelé le SAMU. Ils m'ont dit qu'ils envoyaient une ambulance et que maman faisait sûrement un AVC. »*

Vous demandez à la fille si Mme H. est atteinte de troubles cognitifs. Elle vous répond :
« Non, maman est en pleine santé, elle a juste un traitement pour l'arthrose. »
Elle précise également : *« Vous savez, hier soir, quand je l'ai appelée, elle allait bien. On a discuté et on a même choisi le restaurant où nous devions déjeuner ce midi. »*

- Si pas HGT : diapo suivante.
- Si HGT : passer la prochaine diapo.

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 8 – Mme. H.

Si vous décider de ne pas faire de Glycémie (HGT)

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	88 batt/min
Saturation en oxygène	98%
TA systolique	88 mmHg
TA diastolique	67 mmHg
Glasgow	14
Douleur	Algoplus : 0
Température	36°8C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 8 – Mme. H.

Si vous décider de faire une Glycémie (HGT)

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	88 batt/min
Saturation en oxygène	98%
TA systolique	88 mmHg
TA diastolique	67 mmHg
Glasgow	14
Douleur	Algoplus : 0
Température	36°8C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres (HGT)	101 mg/dL

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 9

Monsieur I, 77 ans

Motif : Dyspnée

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 9 – M. I.

M. I., 77 ans, se présente aux urgences sur les conseils de son infirmière libérale pour une sensation de dyspnée évoluant depuis une semaine.

Il vous dit ce matin : *« Je me sens encore moins bien, et dès que je fais quelque chose, je suis essoufflé. »*
Vous constatez qu'il a du mal à s'exprimer et qu'il doit reprendre son souffle entre ses phrases.

Il y a une semaine, son médecin généraliste l'a mis sous Augmentin® 1 g, 3 fois par jour pendant 7 jours pour une pneumopathie basale droite. Cependant, il vous rapporte que son état ne s'est pas amélioré : *« Ça ne m'a rien fait. »*

Vous entendez que M. I. présente un sifflement à chaque inspiration.

À cet instant, le scope sonne : SpO_2 à 86 %.
Vous décidez d'administrer de l'oxygène à 2 L/min.
Après 2 minutes, la SpO_2 reste inchangée, vous augmentez à 4 L/min, toujours sans effet au bout de 2 minutes, puis passez à 6 L/min.

Vous précisez à M. I. qu'il doit respirer par le nez, mais il vous répond : *« Je respire mieux par la bouche. »*
Vous passez alors au masque à haute concentration, ce qui permet d'obtenir une SpO_2 à 96 %.

En le déshabillant, vous remarquez la présence de marbrures bilatérales au niveau des deux genoux, ainsi qu'un tirage intercostal à chaque inspiration.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 9 – M. I.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	101 batt/min
Saturation en oxygène	86% AA 96% avec O2 6L/min
TA systolique	85 mmHg
TA diastolique	54 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 2/10
Température	37°7C
Fréquence respiratoire	32 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 10

Madame J, 21 ans

Motif : Plaie

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 10 – Mme. J.

Mme J., 21 ans, se présente au SAU pour une prise en charge d'une plaie à la main droite.

À l'IOA, la patiente tient sa main enveloppée dans un torchon et vous dit : *« Désolé, j'ai mis un torchon pour faire un pansement. »*
Vous constatez que celui-ci est imbibé de sang.

Elle vous explique : *« J'étais en train de couper des pommes de terre avec une mandoline pour faire un gratin dauphinois. C'est ma spécialité. J'ai voulu utiliser une mandoline… je n'aurais pas dû. »*

Vous retirez le *« pansement »* improvisé et découvrez une plaie de 3 cm au niveau de la dernière phalange de l'index droit, avec un saignement actif. En nettoyant la plaie au sérum physiologique, vous constatez également une perte de matière.

Elle ajoute : *« Franchement, j'ai beaucoup saigné. J'ai mis la plaie sous l'eau, mais ça ne s'arrêtait pas, alors j'ai pris le torchon et je suis venue. »*

Mme J. est suivie pour une endométriose, pour laquelle elle prend une pilule contraceptive en continu.

- Si pas Hémocue : diapo suivante
- Si Hémocue : passer à la diapo suivante

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 10 – Mme. J.

Si vous décider de ne pas faire d'Hémocue

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	96 batt/min
Saturation en oxygène	100% AA
TA systolique	132 mmHg
TA diastolique	78 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 5/10
Température	36°9C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 10 – Mme. J.

Si vous décider de faire un Hémocue

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	96 batt/min
Saturation en oxygène	100% AA
TA systolique	132 mmHg
TA diastolique	78 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 5/10
Température	36°9C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres (Hémocue)	1 : 11,8 ; 2 : 11,7 ; Moyenne : 11,75

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 11

Monsieur K, 44 ans

Motif : Toux

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 11 – M. K.

M. K., 44 ans, se présente ce jour aux urgences pour une toux associée à une asthénie.

À l'IOA, le patient vous explique : *« Je tousse depuis une semaine et je suis épuisé. Je peux m'allonger ? »*
Vous lui expliquez que vous devez d'abord terminer le recueil des informations avant d'évaluer s'il nécessite d'être allongé.

Il poursuit : *« Ça fait mal, votre truc là ! »* en parlant du brassard à tension. Vous lui demandez de ne pas bouger, mais malgré cela, votre scope affiche **?** / **?**.

Vous lui expliquez que vous allez reprendre une tension et qu'il doit impérativement garder le bras immobile.

En poursuivant l'entretien, vous lui demandez s'il a des expectorations. Il répond : *« Ouais, dès que je tousse, je dois cracher. C'est jaune et vraiment épais. Puis j'ai aussi du mal à avaler, il n'y a que le Coca qui passe actuellement. »*

Antécédents médicaux :
- Opéré d'une hernie inguinale droite.
- Hypercholestérolémie, mais sans traitement.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 11 – M. K.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	65 batt/min
Saturation en oxygène	99%
TA systolique	135 mmHg
TA diastolique	78 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 6/10
Température	37°1C
Fréquence respiratoire	16 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 12

Madame L, 39 ans

Motif : Douleur lombaires

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 12 – Mme L.

Mme L., 39 ans, célibataire, préparatrice en pharmacie.

Hier, elle a ressenti une violente douleur au niveau du dos.
Elle précise : *« J'ai voulu porter un carton pour le ranger sur une étagère en hauteur, j'ai entendu mon dos craquer et je suis tombée par terre avec une douleur horrible. »*

Elle n'a pas eu de traumatisme crânien ni de perte de connaissance.

Elle ajoute : *« Une de mes collègues m'a donné un Ixprim® 37,5 mg/325 mg, puis ils m'ont aidée à me relever. J'ai fini ma journée, mais pas sans peine, et cette nuit, c'était horrible tellement j'avais mal. J'ai pris du Doliprane®, mais ça n'a eu aucun effet antalgique. »*

Elle présente des difficultés à la marche, et le changement de position allongée/assise ou assise/debout est très douloureux.

Elle préfère rester debout lors de l'IOA.

Elle vous dit : *« Ce n'est pas la première fois, mon dos est fragile, j'ai déjà fait deux lumbagos. »*
Elle n'a pas d'autres antécédents médicaux.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 12 – Mme L.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	76 batt/min
Saturation en oxygène	100% A.A
TA systolique	148 mmHg
TA diastolique	86 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 8/10
Température	36°8C
Fréquence respiratoire	18 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 13

Monsieur M, 56 ans

Motif : Crise Convulsive

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 13 – Mr. M.

M. M, 56 ans, SDF, vivant dans la rue depuis plusieurs années.

Il est originaire d'un pays de l'Est et maîtrise peu le français, mais parle anglais.

Ce sont les pompiers qui l'ont transporté aux urgences. Ils le connaissent bien et vous transmettent les informations suivantes :
« M. M., 56 ans, connu de tous, en état d'ébriété, aurait bu plusieurs bières. Nous avons été appelés par des témoins qui l'ont vu tomber du banc de l'arrêt de bus et convulser au sol. Selon eux, la crise aurait duré environ 4 minutes. Il présente une morsure de langue et une perte d'urine. »

Le pompier précise également que le patient est connu du service, où il est déjà venu pour divers motifs, notamment pour des crises d'épilepsie. Il est traité par Keppra® 500 mg.

Recueil de données à l'IOA
Lors de votre entretien, M. M. vous dit :
« Yes, I drank so much today. I drank many beers and two vodkas. »
En effet, il présente une haleine œnolique.

De plus, il dégage une odeur nauséabonde, son pantalon est souillé et mouillé. Il vous précise cependant :
« It's not urine, it's alcohol because I drank many beers. »
Vous remarquez également du sang séché au niveau de la commissure des lèvres. Pourtant, M. M. insiste sur le fait qu'il ne s'est pas mordu la langue.

Vous lui demandez de souffler dans l'éthylomètre afin d'évaluer approximativement son taux d'alcoolémie. Cependant, au moment de souffler, il ne respecte pas les consignes et met l'embout dans sa bouche au lieu de souffler. Après trois tentatives infructueuses, M. M. ne comprend toujours pas les consignes, se montre peu coopératif et vous dit :
« I want to pee. I want to go to the WC. »

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 13 – Mr. M.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	76 batt/min
Saturation en oxygène	99% A.A
TA systolique	138 mmHg
TA diastolique	74 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 0/10
Température	36°1C
Fréquence respiratoire	16 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 14

Madame N, 34 ans

Motif : AVP

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 14 – Mme. N.

Mme N., 34 ans, mariée, enceinte de 24 semaines d'aménorrhées, travaille en tant que greffière.

À 8h30, Mme N. est transportée aux urgences par les pompiers pour la prise en charge d'un accident de la voie publique (AVP).

Dans la salle d'attente, vous vous dirigez vers Me N. et les pompiers pour les transmissions. Vous constatez que Mme N. est allongée sur un plan dur et porte un collier cervical.

Le pompier vous transmet :
« Femme de 34 ans, AVP impliquant un véhicule léger contre un véhicule léger. Elle a été percutée à l'arrière alors qu'elle était à l'arrêt. Patiente ceinturée, les airbags ne se sont pas déclenchés et il n'y a pas eu de traumatisme. Elle présente des douleurs au niveau des cervicales, c'est pourquoi nous l'avons immobilisée sur un plan dur et avons mis en place un collier cervical. »
Il précise également que la patiente est enceinte de 5 mois et n'a aucun antécédent médical.

Vous interrogez rapidement la patiente avant son transfert sur le brancard. Elle vous dit :
« J'ai mal au niveau de la nuque, mais pas du dos. »

Vous appelez le MAO pour un avis. Après évaluation, il vous conseille de maintenir le collier cervical et le plan dur en place.
À l'IOA, la patiente ne présente aucun déficit sensitivomoteur des 4 membres. Cependant, elle vous rapporte :
« Je n'ai aucun souvenir. Je sais juste que j'étais arrêtée dans les bouchons, puis après c'est le trou noir. Je me souviens que les pompiers m'ont retirée de la voiture et m'ont directement allongée sur la civière. »

Elle ajoute : *« J'ai très mal à l'épaule gauche »* et *« J'espère que mon bébé n'a rien, mais je le sens bouger, donc c'est bon signe, non ? »*

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 14 – Mme. N.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	114 batt/min
Saturation en oxygène	100% A.A
TA systolique	135 mmHg
TA diastolique	78 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 8/10
Température	36°6C
Fréquence respiratoire	24 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 15

Monsieur O,16 ans

Motif : Panaris

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 15 – M. O.

M. O., 16 ans, lycéen.

Aujourd'hui, il se présente aux urgences, accompagné de sa mère pour la prise en charge d'un abcès au niveau du pouce de la main droite.

Cela fait deux semaines que le patient présente cet abcès, qui est un panaris. Il a consulté un médecin généraliste il y a une semaine, qui lui a prescrit Pyostacine® 500 mg, 3x/jour pendant 7 jours. Il n'y a pas eu d'amélioration, à l'exception d'un écoulement purulent depuis deux jours.

Il vous dit : « C'est douloureux et je sens les battements de mon cœur dans mon pouce. »

Pour donner suite à un appel au médecin par sa mère, ce dernier leur a conseillé de se rendre aux urgences pour un avis chirurgical.

M. O. a déjà été opéré dans son enfance d'une orchidopexie et d'une appendicectomie.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 15 – M. O.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	78 batt/min
Saturation en oxygène	100% A.A
TA systolique	101 mmHg
TA diastolique	56 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 4/10
Température	36°6C
Fréquence respiratoire	20 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 16

Madame P, 45 ans

Motif : Rectorragie

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 16 – Mme P

Mme P., 45 ans, se présente au SAU pour des rectorragies.

Elle vous explique : *« Depuis deux jours, j'ai du sang quand je vais à la selle. »*

Elle précise que les selles ne sont pas rouges, mais qu'il y a du sang sur le papier quand elle s'essuie, et qu'elle ressent de la douleur à la défécation.

Elle mentionne *« avoir des boules au niveau de l'anus ».* Elle a déjà été opérée pour des hémorroïdes il y a quelques années.

Elle a également subi une césarienne lors de la naissance de sa fille.

- Si pas Hémocue : diapo suivante
- Si Hémocue : diapo passer la prochaine diapo

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 16 – Mme P

Si vous décider de ne pas faire d'Hémocue

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	81 batt/min
Saturation en oxygène	99% en 1.1
TA systolique	138 mmHg
TA diastolique	76 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 6/10
Température	37°2C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 16 – Mme P

Si vous décider de faire un Hémocue

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	81 batt/min
Saturation en oxygène	99% en 1.1
TA systolique	138 mmHg
TA diastolique	76 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 6/10
Température	37°2C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres (Hémocue)	1 : 13,6 ; 2 : 11,9 ; Moyenne : 12,75

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situations 17

Monsieur Q, 32 ans

Motif : Douleur membre inférieur

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 17 – M. Q

M. Q, 32 ans, se présente aujourd'hui au SAU pour des douleurs au niveau du membre inférieur gauche depuis 3 jours.

Il a consulté son médecin généraliste car sa jambe est devenue enflée et rouge. Ce dernier a suspecté une phlébite et a prescrit un bilan sanguin.

Il a réalisé le bilan sanguin ce matin, et les D-dimères sont à 1,45. Le laboratoire l'a appelé pour lui dire de se rendre en urgence au SAU. Il est paniqué car il a peur que ce soit grave.

Au cours de l'IOA, il vous explique qu'il a mal lorsqu'il marche et que sa jambe est « dure comme un caillou ».

Vous constatez que le mollet de M. Q est chaud, induré et douloureux à la palpation. Il est suivi en ville pour un asthme, pour lequel il utilise de la Ventoline® en cas de crise. Il est également sujet à des allergies au pollen et à la pénicilline.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 17 – M. Q

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	76 batt/min
Saturation en oxygène	98% en A.A
TA systolique	141 mmHg
TA diastolique	81 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 8/10
Température	37°5C
Fréquence respiratoire	18 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 18

Madame R, 18 ans

Motif : Traumatisme cheville

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 18 – Mme R

Mme R, 18 ans, se présente aujourd'hui aux urgences après une mauvaise réception au niveau de la cheville droite lors de son match de basket, hier.

Elle n'a pas entendu de craquement et, après l'intervention de son coach, elle a pu terminer son match. Cette nuit, la douleur étant présente, elle a pris 1 g de Doliprane®.

Ce matin, en se levant, elle a remarqué que sa cheville avait « gonflé » et qu'elle avait un hématome sur la face externe de la malléole.

Elle a mis de la glace, mais en raison de la douleur à la marche, elle a préféré se rendre aux urgences pour passer une radio. Elle prend un traitement contre l'acné (Roaccutan®).

- Si vous décider de prendre les paramètres vitaux : diapo suivante
- Si vous décider de ne pas prendre de paramètres vitaux : diapo passer la prochaine diapo

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 18 – Mme R

Si vous décider de prendre les P.V

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	65 batt/min
Saturation en oxygène	100% en A.A
TA systolique	125 mmHg
TA diastolique	77 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 4/10
Température	36°7C
Fréquence respiratoire	12 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 18 – Mme R

Si vous décider de ne pas prendre les P.V

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	/
Saturation en oxygène	/
TA systolique	/
TA diastolique	/
Glasgow	15
Douleur	EN : 4/10
Température	/
Fréquence respiratoire	
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 19

Monsieur S, 73 ans

Motif : O.M.I

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 19 – M. S

M. S, 73 ans, se présente aux urgences via une ambulance pour une prise en charge d'« œdème des membres inférieurs ».

Les constantes, selon l'ambulancier qui vous fait les transmissions, sont normales. Il vous les montre sur un bout de papier dans son calepin.

À l'IOA, M. S. présente des œdèmes des deux membres inférieurs, qui sont rouges. Il n'a pas de douleur mais signale que depuis quelques jours il a des difficultés à respirer et se sent essoufflé au moindre effort.

Il a consulté son médecin généraliste il y a 4 jours pour ce problème. Le médecin pensait qu'il s'agissait d'un « érysipèle » et lui a prescrit de l'Augmentin® 1 g, 3 fois par jour, pendant 7 jours.

Le patient ne constate pas d'amélioration, et surtout, ses « jambes n'ont pas dégonflé ». Il a de nombreux antécédents pour lesquels il est bien suivi. Il est porteur d'un pacemaker et suivi pour un syndrome d'apnée du sommeil, de l'hypertension artérielle, du cholestérol, ainsi que pour une hépatite B guérie. Il a également fait un hématome sous-dural non opéré. Il prend du Xarelto® 10 mg, du Lercan® 10 mg, du Tahor® 40 mg et du Kardégic® 75 mg.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 19 – M. S

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	104 batt/min
Saturation en oxygène	94% en A.A
TA systolique	101 mmHg
TA diastolique	76 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 3/10
Température	36°8C
Fréquence respiratoire	14 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 20

Monsieur T, 46 ans

Motif : Psychiatrie

HÔPITAUX Paris
Saint-Joseph
Marie-Lannelongue

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 20 – M. T.

M. T, 46 ans, se présente aux urgences pour des idées suicidaires dans un contexte de situation familiale compliquée.

M. T. vient de divorcer de sa femme, qui est retournée dans son pays natal avec leurs deux enfants. M. T. est en pleine démarche pour essayer de récupérer la garde de ses enfants, mais il est actuellement en attente de procès.

Depuis le divorce, M. T. est retourné vivre chez ses parents, avec qui la situation est également compliquée, car, selon lui, « ils ne comprennent pas la situation ».

Lors de l'IOA, M. T. déclare *« vouloir en terminer avec tout ça », « je vais me tirer une balle ou me jeter sous un pont, au moins je serai tranquille », « je ne dors plus la nuit, je fais cauchemar sur cauchemar », et « je ne reverrai plus mes enfants, mais eux ils seront tranquilles ».*

Il est en pleurs pendant l'entretien. M. T. est suivi depuis des années par un CMP et est atteint de troubles dépressifs, pour lesquels il suit un traitement à base de Sertraline 50 mg et de Miansérine 10 mg. Il est calme et coopérant.

Infirmier Organisateur de l'Accueil - Cas cliniques préparatoires

Situation 20 – M. T.

Paramètres vitaux à l'IOA	
Fréquence Cardiaque	98 batt/min
Saturation en oxygène	100% en A.A
TA systolique	178 mmHg
TA diastolique	92 mmHg
Glasgow	15
Douleur	EN : 0/10
Température	36°6C
Fréquence respiratoire	20 mvt/min
Autres	

3Q2C	Réponse
Quoi ?	
Qui ?	
Quand ?	
Comment ?	
Combien ?	

→ Tri IOA ?

→ Soins IDE à l'IOA ?

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

A vous la pratique maintenant